

Epilepsi (Sara Hastalığı) Nedir? Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Epilepsi (sara hastalığı), beyindeki sinir hücrelerinin (nöronların) anormal ve aşırı elektriksel aktivitesi sonucu ortaya çıkan, tekrarlayan nöbetlerle karakterize kronik bir nörolojik hastalıktır.

Epilepsi nöbetleri kısa süreli olabilir ve kişinin bilinç, hareket, duyu veya algı durumunu geçici olarak etkileyebilir. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen epilepsi, doğru tanı ve tedavi ile çoğu hastada kontrol altına alınabilen bir hastalıktır.

Epilepsi Nöbet Türleri Nelerdir?

Epilepsi nöbetleri genellikle iki ana gruba ayrılır:

1. Fokal (Parsiyel) Nöbetler

Fokal nöbetler, beynin belirli bir bölgesinde başlayan nöbetlerdir.

Bu nöbetlerde görülebilen belirtiler:

- Vücudun bir bölümünde istemsiz kasılma veya seğirme
- Ani korku veya garip hisler
- Déjà vu (daha önce yaşanmışlık hissi)
- Koku veya tat halüsinasyonları
- Bilinç bulanıklığı
- Çevreyle iletişimde zorlanma

Bazı fokal nöbetler ilerleyerek tüm beyne yayılabilir ve jeneralize nöbetlere dönüşebilir.

2. Jeneralize Nöbetler

Jeneralize nöbetler beynin her iki yarım küresini aynı anda etkiler.

En sık görülen jeneralize nöbet türleri:

Tonik-Klonik Nöbet (Büyük Nöbet)

- Bilinç kaybı
- Vücudun kasılıp gevşemesi

- Kol ve bacaklarda ritmik kasılmalar
- Ağızdan köpük gelmesi
- Nöbet sonrası yoğun uyku hali

Absans Nöbeti (Dalma Nöbeti)

- Kısa süreli dalma
- 5–10 saniye süren bilinç kaybı
- Çocuklarda daha sık görülür

Miyoklonik Nöbet

- Ani ve kısa süreli kas sığramaları

Atonik Nöbet

- Kas tonusunun aniden kaybolması
- Ani düşmeler

Epilepsi Nöbeti Belirtileri Nelerdir?

Epilepsi nöbetlerinin belirtileri kişiden kişiye ve nöbet türüne göre değişebilir.

En sık görülen belirtiler:

- Bilinç kaybı veya dalma
- Vücutta kasılma veya titreme
- Anlamsız veya tekrarlayan hareketler
- Gözlerin sabit bir noktaya bakması
- Dil ısırma
- İdrar kaçırma
- Nöbet sonrası baş ağrısı ve yorgunluk

Epilepsi İçin Ne Zaman Doktora Başvurulmalı?

Aşağıdaki durumlarda mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurulmalıdır:

- İlk kez nöbet geçirilmesi

- Nöbetin 5 dakikadan uzun sürmesi
- Nöbetlerin sıklaşması
- Nöbet sonrası bilincin uzun süre açılmaması

Bu durumlar acil değerlendirme gerektirebilir.

Epilepsi Neden Olur?

Epilepsinin birçok farklı nedeni olabilir. Ancak bazı hastalarda kesin neden belirlenemeyebilir.

1. Genetik (Kalıtsal) Nedenler

Bazı epilepsi türleri genetik yatkınlık ile ilişkilidir.

- Nöbetler genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başlar
- Ancak her epilepsi hastasında aile öyküsü bulunmayabilir.

2. Beyin Hasarına Bağlı Epilepsi

Epilepsi bazı durumlarda beyinde oluşan hasar sonrası gelişebilir.

Doğum Öncesi veya Doğum Sırası Problemleri

- Doğum sırasında oksijensiz kalma
- Prematüre doğum
- Doğumsal beyin gelişim bozuklukları

Beyin Travması

- Trafik kazaları
- Kafa travmaları

Beyin Damar Hastalıkları

- İnme (felç)
- Beyin kanaması

Beyin Tümörleri

Beyindeki bazı kitleler epileptik nöbetlere yol açabilir.

Beyin Enfeksiyonları

- Menenjit
- Ensefalit

Metabolik ve Sistemik Hastalıklar

- Kan şekeri düşüklüğü
- Elektrolit bozuklukları
- Böbrek veya karaciğer yetmezliği

3. Nedeni Bulunamayan Epilepsi

Bazı hastalarda tüm tetkikler normal olabilir. Bu durum idiopatik epilepsi olarak adlandırılır.

Epilepsi Hangi Yaşlarda Daha Sık Görülür?

Epilepsi her yaşta ortaya çıkabilir. Ancak şu dönemlerde daha sık görülür:

- Çocukluk dönemi
- 65 yaş sonrası

Yaşlılarda epilepsinin en sık nedeni genellikle inme veya beyin damar hastalıklarıdır.

Epilepsi Tanısı Nasıl Konur?

Epilepsi tanısı genellikle aşağıdaki değerlendirmeler ile konur:

1. Nöbetlerin ayrıntılı hikayesinin alınması
2. Nörolojik muayene
3. EEG (Elektroensefalografi) incelemesi
4. Gerekli durumlarda beyin MR görüntülemesi

Bu bilgiler birlikte değerlendirilerek tanı konur.

Epilepsi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Epilepsi tedavisinin temel amacı:

- Nöbetleri tamamen durdurmak veya en aza indirmek
- Hastanın yaşam kalitesini korumak
- İlaç yan etkilerini en düşük seviyede tutmak

1. Antiepileptik İlaç Tedavisi

Epilepsi hastalarının yaklaşık %70'i düzenli ilaç tedavisi ile nöbetsiz hale gelebilir.

Doktorlar ilaç seçerken şu faktörleri değerlendirir:

- Nöbet türü
- Hastanın yaşı
- EEG ve MR sonuçları
- Yan etki riski

Önemli noktalar:

- İlaçlar her gün düzenli kullanılmalıdır
- Doktor önerisi olmadan ilaçlar kesilmemelidir
- Doz ayarlamaları kademeli yapılır

2. Cerrahi Tedavi

Bazı hastalarda ilaç tedavisi yeterli olmaz. Bu durum ilaç dirençli epilepsi olarak adlandırılır.

Eğer nöbetlerin çıktığı beyin bölgesi net olarak belirlenirse epilepsi cerrahisi uygulanabilir.

3. Vagus Sinir Stimülasyonu (VNS)

İlaç ve cerrahiye uygun olmayan hastalarda vagus sinir stimülasyonu kullanılabilir.

Bu yöntemde sinir uyarıcı bir cihaz nöbetlerin sıklığını azaltabilir.

4. Ketojenik Diyet

Özellikle çocukluk çağında bazı epilepsi türlerinde ketojenik diyet uygulanabilir.

Epilepsi Hastaları İçin Yaşam Tarzı Önerileri

Bazı faktörler epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir.

En sık tetikleyiciler:

- Uykusuzluk
- Aşırı stres
- Alkol kullanımı
- Yanıp sönen ışıklar (bazı hastalarda)
- İlaçların düzensiz kullanımı

Bu nedenle epilepsi hastalarının:

- Düzenli uyuması
- İlaçlarını aksatmaması
- Nöbet tetikleyicilerinden kaçınması

çok önemlidir.